

## Tireoide · hipo, hipertireoidismo e tormenta

Interprete sempre TSH + T4L no contexto clínico. Distinga tireotoxicose por hipertireoidismo verdadeiro de destruição glandular — a conduta com antitireoidiano muda.

### Basedow × tireoidite

#### Lembre - Basedow × tireoidite

Basedow: TRAb+, captação alta, oftalmopatia possível !' metimazol/PTU. Tireoidite: captação baixa, fase destrutiva !' betabloqueador e suporte; antitireoidiano não ajuda.

*Triagem de prova: sintomas + TSH/T4L definem via; emergências exigem suporte e hormônio/bloqueio imediato.*

### Síndromes tireoidianas

Hipo / hiper / emergencia

#### Hipotireoidismo

TSH alto, T4L baixo  
Levotiroxina  
Cuidado em idoso/CAD

**Hashimoto comum**

#### Hipertireoidismo

TSH baixo, T4L alto  
ATD +/- betabloqueador  
Cintilo se duvida

**Basedow / nódulo**

#### Emergencia

Tormenta tireotóxica  
Coma mixedematoso  
UTI + protocolo

**Alta mortalidade**

### Tormenta tireotóxica — pilares

- Suporte: ABC, resfriamento, volume, tratar precipitante (infecção, cirurgia)
- Betabloqueador (propranolol) para sintomas adrenérgicos
- Tionamida (PTU preferido na gravidez 1ºT / tormenta por inibir conversão) + iodo após ATD
- Corticoide para bloquear conversão T4!T3 e insuficiência adrenal relativa

### Achados laboratoriais

#### Condição | Padrão típico

Hipo primário | TSH !', T4L !"

Hiper primário | TSH !", T4L !' (± T3 !')

Hipo central | TSH baixo/inadequado + T4L !"

Tiroxina excesso | TSH !"; diferenciar exógena × endógena

### Armadilha de prova

#### Atenção - Armadilha de prova

No coma mixedematoso: aquecer passivamente, hidrocortisona antes/junto da levotiroxina (pode haver insuficiência adrenal associada) e tratar precipitante. Não atrase hormônio esperando 'todos os exames'.